

Brain & Mind

B&M News

- 미국 FDA, 알츠하이머병 치료제 레카네맵(lecanevab)의
가속승인 결정
- COVID-19의 장기(long-term) 신경학적 결과
- 혈액에서(신경세포 유래) α -synuclein 의 검출:
파킨슨병의 새로운 생물표지자
- 무증상 경동맥 협착증의 치료: SPACE-2의 5년 연구 결과

미국 FDA, 알츠하이머병 치료제 레카네맵(lecaneumab)의 가속승인 결정

미국식품의약국(FDA)이 초기 알츠하이머병의 치료를 위한 신약 레카네맵(lecaneumab)의 가속승인을 결정했다. 2021년 6월 아두카누맵(aducanumab)의 가속승인 이후 두 번째이다. 아두카누맵의 실패와 레카네맵의 부작용 발표 등 그동안 치료 약제들에 대한 우려도 적지 않았지만 알츠하이머병 치료에 대한 세계적인 요구, 필요성에 대한 긍정적 평가가 더 많았다.

뉴잉글랜드 의학저널(New England Journal of Medicine)에 발표된 임상시험 결과에 따르면 레카네맵을 투여받은 사람들은 치료를 받지 않은 사람들에 비해 인지 기능 저하가 18개월 동안 27% 더 느린 것으로 나타났다. 초기 알츠하이머병 및 아밀로이드 PET 베타-아밀로이드를 보이는 환자에서 베타아밀로이드에 대한 단일클론항체, 레카네맵을 주사하고 위약과 비교했다. 전체 1,795명의 환자에서 시행되었고 약물은 2주마다 10 mg/kg으로 투여했다. 1차 평가변수는 임상치매등급(CDR-Sum of boxes) 합계로, 약물과 위약 사이에 0.45점의 차이가 있었다. 앞서 기술한 바와 같이 인지장애의 진행이 27% 감소했으며, 아밀로이드 PET 결과에서도 약물 치료군에서 더 적은 아밀로이드 침착이 관찰되었다. 일부 환자의 MRI에서 뇌부종, 미세출혈 및 뇌출혈과 같은 항체 약물의 전형적인 부작용이 관찰되기도 했으나, 심각하지 않은 부작용은 약물 중단 후 다시 호전되었다.

에자이와 바이오젠은 레카네맵의 미국 내 승인으로 초기 알츠하이머병의 3년 차까지 포함해 약 10만명에 사용될 수 있을 것으로 추산했다. 나이가 아밀로이드 베타 병리를 확인하기 위한 혈액 기반 생물표지자 등을 활용한 새로운 스크리닝을 통해 사용이 점진적으로 증가하고, 관련 연구 및 시장의 확대도 예상했다.

〈참고문헌〉 van Dyck CH, Swanson CJ, Aisen P, Bateman RJ, Chen C, Gee M, Kanekiyo M, Li D, Reyderman L, Cohen S, Froelich L, Katayama S, Sabbagh M, Vellas B, Watson D, Dhadda S, Irizarry M, Kramer LD, Iwatsubo T. Lecaneumab in Early Alzheimer's Disease. N Engl J Med 2023; 388:9-21.

COVID-19의 장기(long-term) 신경학적 결과

COVID-19의 장기(long-term) 신경학적 결과가 Nature Medicine에 발표되었다. COVID-19에 걸린 154,068명의 코호트와 대조군 560만여 명에서 12개월 추적 검사 후의 결과로, 연구 결과 위험비율(hazard ratio, HR) 1.42(95% CI, 1.38~1.47)로 코로나19 이후 신경계 질환 위험이 42% 증가한 것으로 나타났다. 여기에는 뇌졸중, 뇌출혈, 인지 및 기억력 장애, 다발신경병증, 편두통, 뇌전증, 이상운동질환, 근골격계질환, 기영바레증후군, 뇌염 및 뇌병증 등이 포함된다. 이 연구는 백인만을 대상으로 했지만 다른 인종에게도 적용될 수 있을 것으로 보인다. COVID-19의 가능한 장기적인 신경학적 결과를 고려하면서 주의 깊은 추적관찰이 필요하겠다.

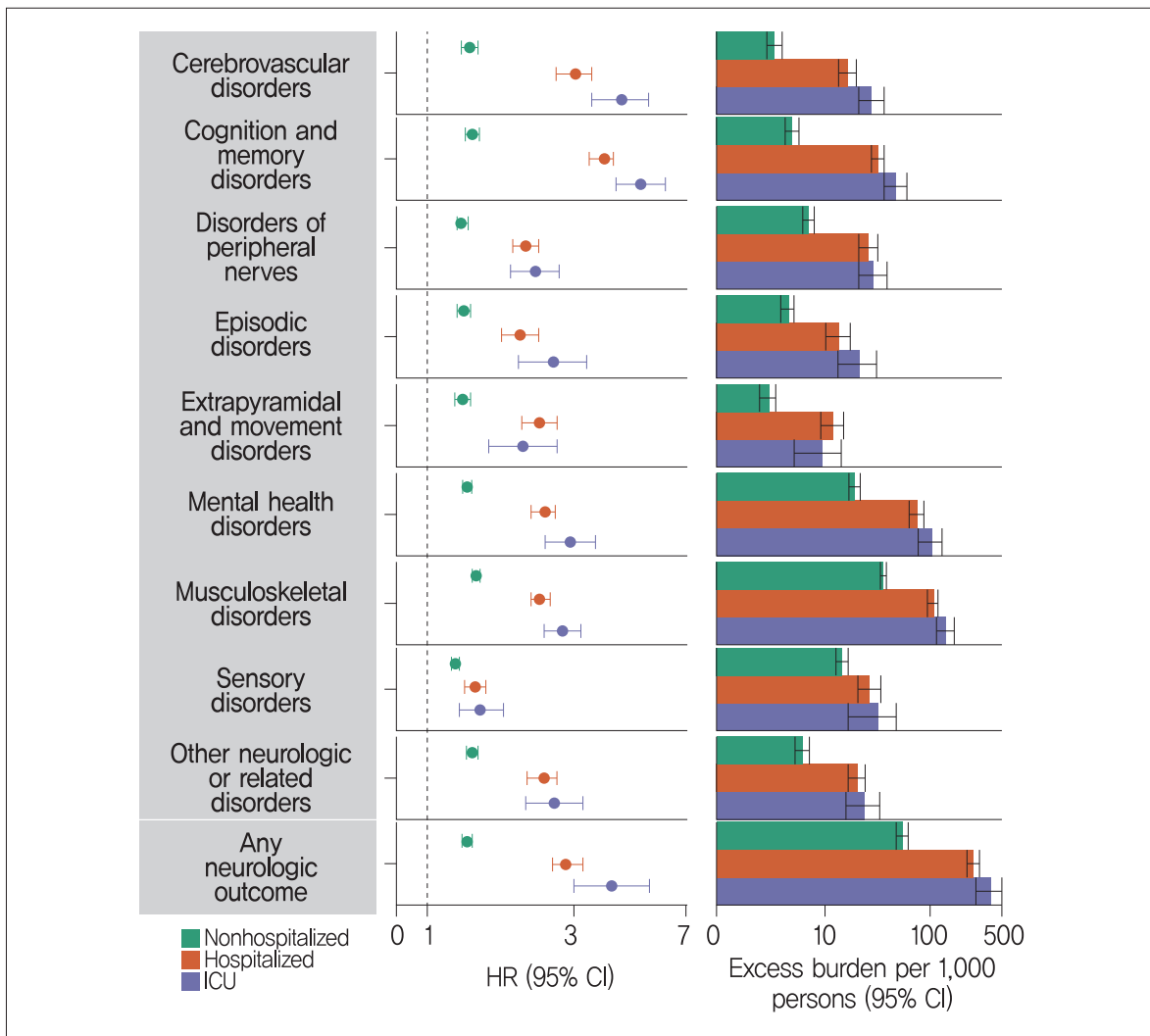


그림 1. Risks and 12-month burdens of incident postacute COVID-19 composite neurologic outcomes compared with the contemporary control cohort by care setting of the acute infection.

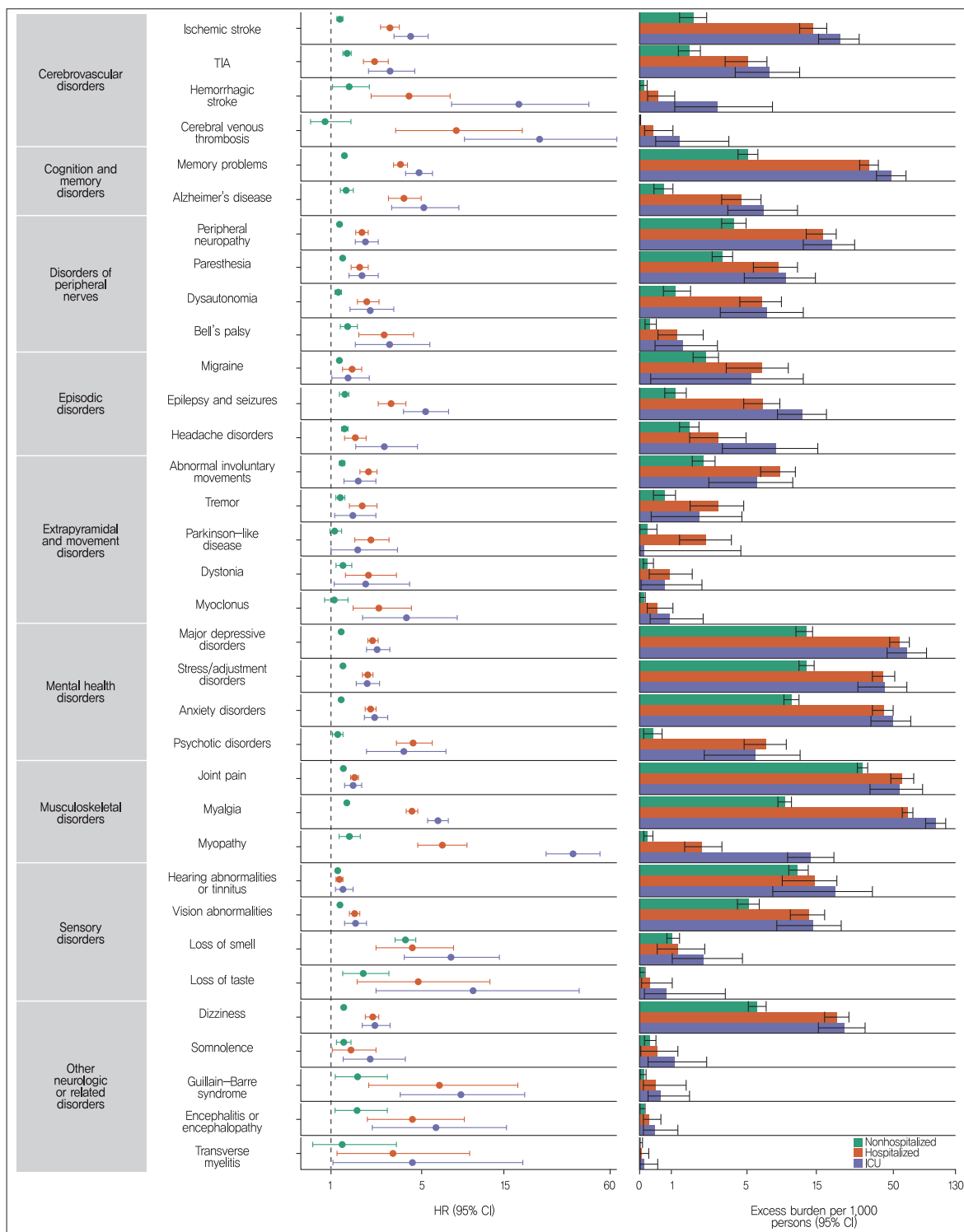


그림 2. Risks and 12-month burdens of incident postacute COVID-19 neurologic outcomes compared with the contemporary control cohort by care setting of the acute infection.

〈참고문헌〉 Evan Xu, Yan Xie, Ziyad Al-Aly. Long-term neurologic outcomes of COVID-19. Nat Med. 2022 Nov;28(11):2406–2415.

혈액에서(신경세포 유래) α -synuclein 의 검출: 파킨슨병의 새로운 생물표지자

(mis-folded) 알파-시누클레인이 파킨슨병의 진행에 중요한 요소라는 것은 잘 알려져 있다. 지금까지는 뇌척수액에서만 알파-시누클레인을 관찰할 수 있었으나, 독일 키엘(Kiel)의 한 그룹에서 혈장에서 알파-시누클레인의 증가를 보고했다. 이는 향후 무작위치료임상시험에 들어갈 수 있는 환자를 식별하는 데 중요한 혈액 생물표지자가 될 것으로 기대된다. 신경퇴행성 질환에서 병리학적 질병 기전을 연구하는 데에도 많은 도움을 줄 것이다.

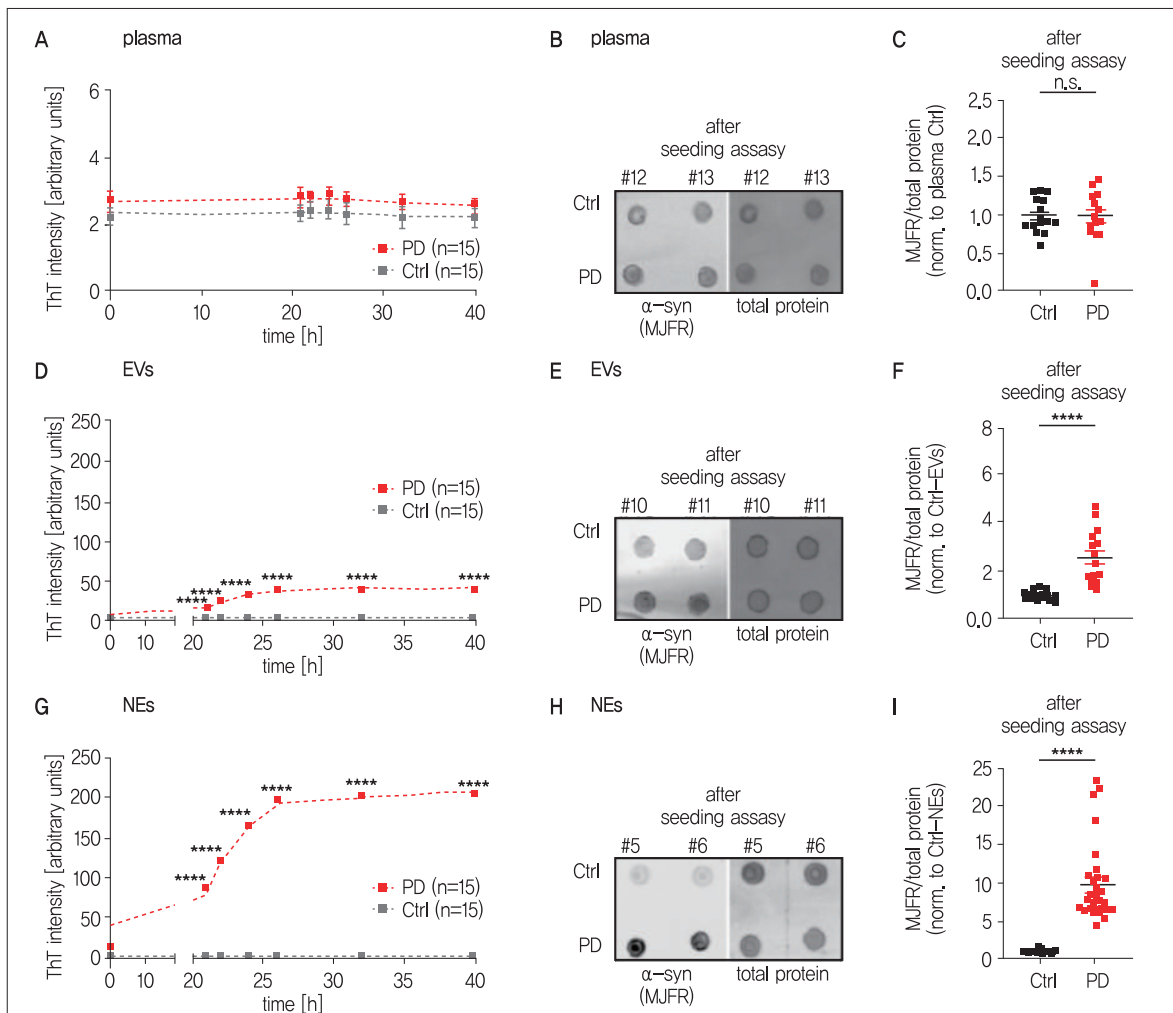


그림 3.

〈참고문헌〉 Kluge A, Bunk J, Schaeffer E, Drobný A, Xiang W, Knacke H, Bub S, Lückstädt W, Arnold P, Lucius R, Berg D, Zunke F. Detection of neuron-derived pathological α -synuclein in blood. *Brain*. 2022 Sep 14;145(9):3058–3071.

무증상 경동맥 협착증의 치료: SPACE-2의 5년 연구 결과

독일 하이델베르크의 한 연구 그룹에서 SPACE-2 연구의 5년 결과를 발표했다. 이 연구에는 513명의 무증상 경동맥 협착증 환자가 포함되었으며, 이들은 다음 두 군으로 무작위 배정되었다: 경동맥 내막절제술 또는 스텐트삽입술을 받는 군과 최상의 내과 치료만 받는 군. 1차 평가변수는 30일 이내의 뇌졸중 또는 사망, 또는 5년 이내 동측 허혈성 뇌졸중이었다. 연구 결과 치료 군 간에 차이가 없었다. 이로써 무증상 경동맥 협착증 환자는 우선 최선의 약물 치료를 받아야 하고, 위험 요인과 동반 질환을 통제할 수 없는 환자에서만 중재적 치료를 고려할 수 있을 것으로 해석된다.

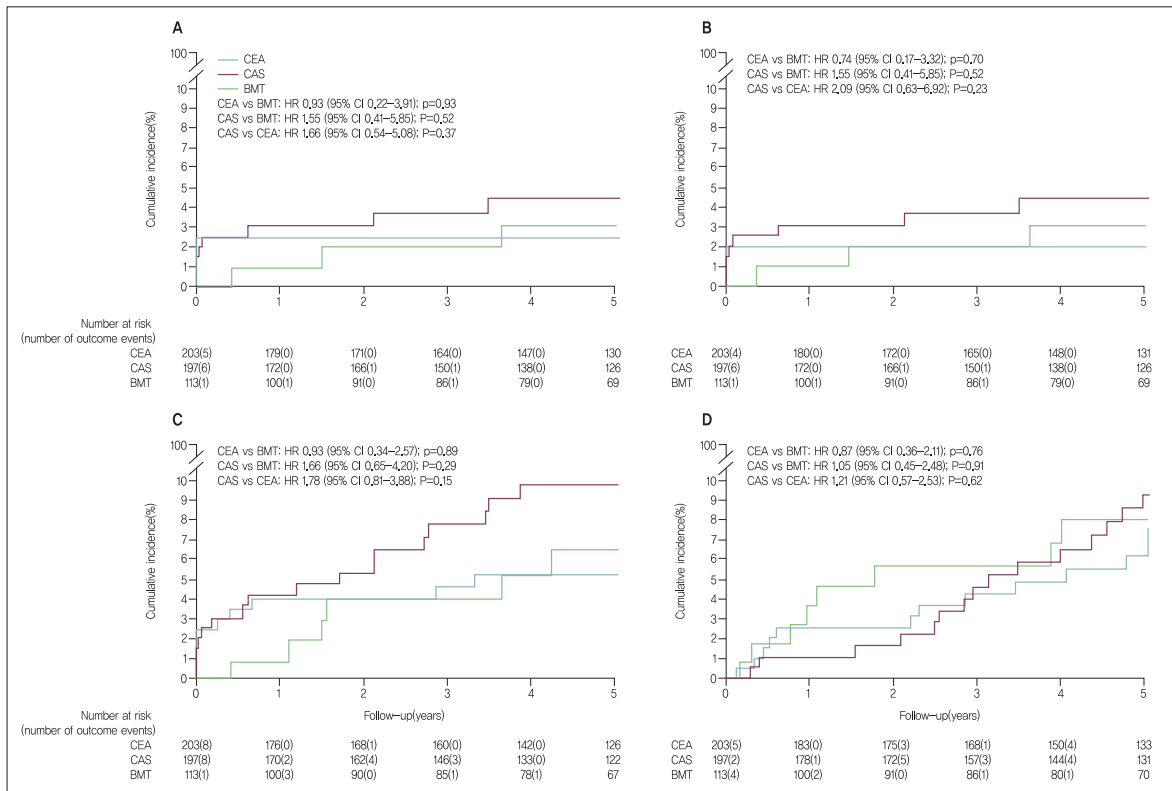


그림 4. Cumulative incidence of primary endpoint events within 5 years.

〈참고문헌〉 Reiff T, Eckstein HH, Mansmann U, Jansen O, Fraedrich G, Mudra H, Böckler D, Böhm M, Debus ES, Fiehler, Mathias K, Ringelstein EB, Schmidli J, Stinge R, Zahn R, Zeller T, Niesen WD, Barlinn K, Binder A, Glahn, Hacke W, Ringel PA; SPACE-2 Investigators. Carotid endarterectomy or stenting or best medical treatment alone for moderate-to-severe asymptomatic carotid artery stenosis: 5-year results of a multicentre, randomised controlled trial. *Lancet Neurol*. 2022 Oct;21(10):877–888.